समक्ष: माननीय जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गाजियाबाद

विकास गांधी बनाम एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (ACKO General Insurance Ltd.)

विषय: एकमात्र शेष मतभेद के बिंदु पर संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण

माननीय महोदय/महोदया,

इस मामले में एको (ACKO) और मेरे बीच लगभग सभी तथ्यों और मुद्दों पर सहमति है। केवल एक ही बिंदु ऐसा है जिस पर मेरा विनम्र निवेदन एको के रुख से भिन्न है:

पॉलिसी अनुसूची (POLICY SCHEDULE) — पृष्ठ 36 / C-01

"जब तक कि दुर्दमता (Malignancy / कैंसर) के कारण आवश्यक न हो, जननांग प्रणाली (Genitourinary System) की किसी भी सर्जरी को कवर नहीं किया जाएगा।"

महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण: मैं यह दावा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि बीएक्सओ (BXO) स्वयं में दुर्दमता (कैंसर) है।

BXO ≠ दुर्दमता (Malignancy)

हालाँकि, बीएक्सओ एक ऐसी स्थिति है जिसमें **चिकित्सकीय रूप से स्वीकृत दुर्दमता / पेनाइल कैंसर (Penile Cancer) का जोखिम शामिल है**।

चिकित्सीय रिकॉर्ड इसका समर्थन करते हैं

- **बायोप्सी — अनुलग्नक C-09, पृष्ठ 98:** "लाइकेन स्क्लेरोसस (बालेनाइटिस जेरोटिका ऑब्लिटेरन्स) के अनुरूप" — BXO।

- **डॉ. वैभव सक्सेना, M.Ch. यूरोलॉजी (AIIMS), पृष्ठ 16:** उन्होंने इसे **"प्री-मैलिग्नेंट कंडीशन (कैंसर से पूर्व की स्थिति)"** के रूप में प्रमाणित किया है; सर्जरी **"अनिवार्य थी"**, **"ऐच्छिक या कॉस्मेटिक नहीं"**; और स्पष्ट किया कि यदि इलाज न किया गया तो **"पेनाइल कैंसर का जोखिम"** था।

- **अस्पताल रिकॉर्ड — पृष्ठ 14:** "मूत्र का धीमा प्रवाह (POOR FLOW OF URINE)" और "मीटल स्टेनोसिस के साथ बालेनाइटिस और टाइट फिमोसिस" — यह पुष्टि करता है कि सर्जरी चिकित्सीय रूप से आवश्यक थी, कॉस्मेटिक या ऐच्छिक नहीं।

बीमा लोकपाल (INSURANCE OMBUDSMAN) के निर्णय का महत्व बीमा लोकपाल ने इस उपचार को **चिकित्सीय रूप से आवश्यक (MEDICALLY NECESSARY)** माना और स्थायी अपवर्जन क्लॉज 4.2.3 को लागू न होने योग्य पाया। उस स्तर पर पाई गई कमी मुख्य रूप से सर्जरी के बाद के मेडिकल दस्तावेजों से संबंधित थी। अब इलाज करने वाले विशेषज्ञ के प्रमाणपत्र द्वारा उस कमी को पूरा कर दिया गया है। — *लोकपाल निर्णय, पृष्ठ 115*।

मेरा प्रश्न यह **नहीं** है: *"क्या मुझे कैंसर था?"* — उत्तर: नहीं।

मेरा प्रश्न यह है: क्या एक **प्री-मैलिग्नेंट स्थिति**, जिसमें दुर्दमता (कैंसर) का चिकित्सीय रूप से स्वीकृत जोखिम मौजूद है और जिसके उपचार को विशेषज्ञ द्वारा आवश्यक प्रमाणित किया गया है, उसे पॉलिसी अपवाद *"जब तक कि दुर्दमता के कारण आवश्यक न हो"* को लागू करते समय पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है?

कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम (CONTRA PROFERENTEM) — वैकल्पिक निवेदन यदि पॉलिसी की शब्दावली में कोई वास्तविक अस्पष्टता पाई जाती है जिसके दो तर्कसंगत अर्थ निकल सकते हैं, तो **कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम** के सिद्धांत के अनुसार उस अस्पष्टता का अर्थ उस पक्ष के विरुद्ध निकाला जाना चाहिए जिसने पॉलिसी का प्रारूप तैयार किया है — यानी बीमा कंपनी — और बीमित व्यक्ति के पक्ष में। यह सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जहाँ वास्तविक अस्पष्टता मौजूद हो।

इसलिए, यदि आयोग को उपरोक्त अपवाद के दायरे में कोई वास्तविक अस्पष्टता मिलती है, तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि पॉलिसी की व्याख्या बीमित व्यक्ति के हित में की जाए।

मेरा विनम्र प्रार्थना-पत्र मैं एको (ACKO) से कोई नई शर्त बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं केवल इतना अनुरोध कर रहा हूँ कि एको के अपने ही लिखित **पॉलिसी अपवाद** को मेरे मामले के वास्तविक चिकित्सीय तथ्यों पर लागू किया जाए।

BXO ≠ दुर्दमता (Malignancy) → स्वीकृत दुर्दमता जोखिम → चिकित्सीय रूप से आवश्यक उपचार

इसलिए, मैं आदरपूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि आयोग इस चिकित्सीय श्रृंखला और जहाँ लागू हो, **कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम** के सिद्धांत पर विचार करे, पॉलिसी अपवाद की उचित व्याख्या करे, और मेरे **₹37,358/-** के दावे के भुगतान का निर्देश दे।

धन्यवाद।